Azienda Ospedaliera Santa Caterina del Reno
Dipartimento di Medicina Specialistica
U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali
Degenza ordinaria - Day Hospital - Ambulatorio HIV
Direttrice: Prof.ssa Marisa Calzolari

Via Larga del Navile 140
40131 Bologna
Degenza 051 6382 210
Ambulatorio HIV 051 6382 245
Fax 051 6382 299
malinfettive@aoscr.example.it

Al sig. Gabriele D'Ambrosio - consegna a mano
e, previo consenso dell'interessato, al Dott. Pierluigi Venturi
Medico di Medicina Generale, Via Irnerio 22, Bologna

LETTERA DI DIMISSIONE

Ricovero ordinario in U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali

DATI DEL PAZIENTE

Cognome e nome:	**D'AMBROSIO GABRIELE**	Sesso:	**M**
Nato a:	**Salerno il 14 luglio 1979**	Stato civile:	**unito civilmente**
Residenza:	**Via Mascarella 63, 40126 Bologna**	Telefono:	**+39 333 718 4402**
Professione:	**grafico pubblicitario**	Datore di lavoro:	**Studio Lanterna Comunicazione S.r.l.**
Tessera sanitaria:	**80380080983847942827**	Esenzione:	**020.042**
N. ricovero:	**2025/MI/004127**	Codice paziente:	**HIV-BO-07731**

Codice fiscale D M B G R L 7 9 L 1 4 H 7 0 3 L

Ricovero:	02/09/2025	Provenienza:	Pronto Soccorso Generale	Dimissione:	22-09-2025
Cartella clinica:	MI-25-1183	Medico referente:	Dott. Lorenzo Mazzacurati	Infermiera case manager:	Monica Grandi

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI SANITARI

Ai sensi della L. 135/1990 il paziente acconsente alla comunicazione della diagnosi a:

- ☒ Medico di Medicina Generale
- ☐ Familiari (madre, sorella)
- ☒ Partner convivente, sig. Samuele Viola
- ☒ Datore di lavoro (solo prognosi)

Persona di riferimento

Partner unito civilmente e contatto di emergenza: sig. Samuele Viola, tel. +39 349 562 0718, samuele.viola@posta.example.it. È l'unica persona autorizzata a ricevere informazioni cliniche, anche telefoniche.

Familiari non autorizzati

La madre, sig.ra Carmela Iannone, residente a Cava de' Tirreni, e la sorella, sig.ra Stella D'Ambrosio, hanno chiesto notizie per telefono il 05/09/2025: sono state fornite solo informazioni generiche, per esplicita volontà del paziente (1).

Gentile Collega,
Ti scrivo in merito al sig. D'Ambrosio, 46 anni, ricoverato presso il nostro reparto dal 2 settembre 2025 al 22.09.25 per insufficienza respiratoria acuta, con nuova diagnosi di infezione da HIV in fase avanzata. Il paziente ha autorizzato per iscritto la trasmissione della presente lettera.

MOTIVO DEL RICOVERO E ANAMNESI

Giunto in PS per febbre serotina da circa 3 settimane, tosse secca, dispnea ingravescente da sforzo e calo ponderale di 9 kg in due mesi. All'ingresso FR 30 atti/min, SpO2 86% in aria ambiente, emogasanalisi con PaO2 54 mmHg; peso 61 kg, altezza 178 cm, BMI 19,3. All'esame obiettivo candidosi orofaringea e lesioni maculo-papulari di colore viola agli arti inferiori.
Anamnesi. Herpes zoster toracico nel 2023; sifilide primaria trattata nel 2018 presso il centro MST di Napoli. Ultimo test HIV negativo nel 2019. Fattore di rischio: rapporti sessuali con partner dello stesso sesso. Riferito uso occasionale di mefedrone e GHB in contesto di chemsex; non fumo, alcol occasionale. Nessuna allergia nota all'ingresso (vedi decorso). Vive a Bologna con il partner dal 2016.

ESAMI PRINCIPALI

Esame	02/09	15/09	21/09	U.M.
Linfociti T CD4+	38	-	71	cell/µL
CD4+ percentuale	4,1%	-	6,8%	%
HIV-1 RNA	412.000	-	1.940	copie/mL
LDH	612	388	251	U/L
Beta-D-glucano	> 500	-	-	pg/mL

Esame	02/09	15/09	21/09	U.M.
Emoglobina	10,9	10,2	11,4	g/dL
Potassio	4,3	5,9	4,6	mmol/L
CMV-DNA plasmatico	840	-	non rilevabile	UI/mL

Codici campione del laboratorio di microbiologia; il referto di genetica (2) è archiviato nel fascicolo di G. D'Ambrosio.

Indagine	Data	Codice / accesso	Esito
Test HIV Ag/Ab combo + Western blot	02/09/2025	SI25-0902-0417	HIV-1 positivo, confermato
Broncoscopia con BAL (Dott.ssa Irene Fabbri)	04/09/2025	BAL25-00981	PCR e immunofluorescenza positive per Pneumocystis jirovecii; colture batteriche e micobatteri negative
TC torace senza mdc	03/09/2025	CT25-118402	opacità a vetro smerigliato bilaterali, prevalenti ai lobi superiori
Biopsia cutanea gamba sinistra	08/09/2025	IST25-07726	sarcoma di Kaposi, HHV-8 positivo all'immunoistochimica
Sierologia sifilide (TPHA/RPR)	02/09/2025	SI25-0902-0418	TPHA positivo, RPR 1:16
Test di resistenza genotipico	05/09/2025	GRT-25-0322	sottotipo B, nessuna mutazione di resistenza rilevante
HLA-B*57:01	05/09/2025	HLA-25-1094	HLA-B*57:01 negativo

DECORSO CLINICO

All'ingresso avviata ossigenoterapia con alti flussi (FiO2 0,45) e terapia empirica; dopo il BAL del 4 settembre diagnosi di polmonite da Pneumocystis jirovecii in infezione da HIV-1 in stadio C3 (AIDS). Terapia con trimetoprim-sulfametossazolo 15 mg/kg/die e prednisone 40 mg due volte al giorno secondo schema, con progressivo miglioramento degli scambi respiratori: in aria ambiente dal 11/09/2025. Il 14/09/2025 comparsa di esantema maculo-papulare da cotrimossazolo con iperkaliemia (potassio 5,9 mmol/L): terapia proseguita a dosaggio ridotto con antistaminico, con risoluzione del rash in 4 giorni (consulenza dermatologica della Dott.ssa Chiara Nguyen).

Il 16/09/2025, a 14 giorni dall'inizio della terapia per la polmonite, è stata avviata la terapia antiretrovirale con bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide, ben tollerata. La sifilide latente tardiva è stata trattata con penicillina G benzatina 2,4 MUI i.m. (prima dose il 10/09/2025, seconda il 17/09/2025) dopo test di tolleranza. Riscontro di viremia da CMV a bassa carica, senza retinite all'esame del fundus (Dott. Ruggero Tassinari, Oculistica); negativizzata senza terapia.

Il sarcoma di Kaposi cutaneo (stadio T0 I0 S1) è stato discusso con l'oncologo Dott. Andrea Melandri: si attende la risposta all'immunoricostituzione prima di valutare la chemioterapia.

Alla comunicazione della diagnosi il paziente ha presentato una reazione di adattamento con ansia; ha effettuato tre colloqui con la psicologa dott.ssa Beatrice Lolli e chiede di proseguire il supporto. Il partner, sig. Viola, è stato informato con il consenso del paziente il 06/09/2025 e si è sottoposto al test HIV, risultato negativo; è stato indirizzato al counselling per la PrEP. Il paziente è stato assistito durante il ricovero dalla specializzanda dott.ssa Agnese Tura e dal coordinatore infermieristico Nicola Pancaldi.

DIAGNOSI ALLA DIMISSIONE

1. **Infezione da HIV-1 in stadio C3 (AIDS) di nuova diagnosi** (CD4 nadir 38 cell/µL).
2. Polmonite da Pneumocystis jirovecii con insufficienza respiratoria acuta ipossiemica, in risoluzione.
3. Sarcoma di Kaposi cutaneo (HHV-8 correlato).
4. Sifilide latente tardiva, in trattamento; candidosi orofaringea, risolta.
5. Reazione cutanea da cotrimossazolo (non grave, non controindica la profilassi).
6. Disturbo dell'adattamento con ansia.

TERAPIA ALLA DIMISSIONE

Farmaco	Dose	Orari	Note
Bictegravir 50 mg / emtricitabina 200 mg / tenofovir alafenamide 25 mg	1 cpr	ore 20	non assumere insieme ad antiacidi o integratori di ferro e calcio; distribuzione diretta dalla farmacia ospedaliera
Cotrimossazolo 800/160 mg	1 cpr	ore 8	profilassi secondaria; sospendere solo con CD4 > 200 cell/µL per 3 mesi
Prednisone 20 mg	1 cpr	ore 8	fino al 24/09/2025, poi sospendere (completa 21 giorni)
Penicillina G benzatina 2,4 MUI	1 fl i.m.	-	terza dose il 24/09/2025 presso il Day Hospital
Cetirizina 10 mg	1 cpr	ore 21	per 7 giorni
Pantoprazolo 20 mg	1 cpr	ore 7	fino al termine dello steroide

CONTROLLI PROGRAMMATI

Servizio	Referente	Data	Prenotazione / recapito
Day Hospital Malattie Infettive	inf. Monica Grandi	24/09/2025 ore 9:00	DH-MI-25-03381
Ambulatorio HIV	Dott. Lorenzo Mazzacurati	07/10/2025 ore 11:30	CD4, HIV-RNA, funzione renale 051 6382 245
Ambulatorio di Oncologia Medica	Dott. Andrea Melandri	21/10/2025 ore 14:00	CUP-BO-25-551870

Servizio	Referente	Data	Prenotazione / recapito
Supporto psicologico	dott.ssa Beatrice Lolli	da concordare	psicologia.mi@aoscr.example.it

Si raccomanda: vaccinazione anti-pneumococcica e anti-HBV dopo il recupero dei CD4 (HBsAg e anti-HBs negativi); screening per HPV anale; uso del profilattico. Il sig. Gabriele è stato informato che, con viremia stabilmente non rilevabile, il rischio di trasmissione sessuale è nullo (U=U). La certificazione per il datore di lavoro riporta la sola prognosi.

Il Medico Referente

Dott. Lorenzo Mazzacurati
Dirigente Medico - Malattie Infettive

AZ. OSP. SANTA CATERINA DEL RENO
U.O.C. MALATTIE INFETTIVE
Dott. L. Mazzacurati
Ord. Medici BO n. 18842

Bologna, 22 settembre 2025

La Direttrice dell'U.O.C.

Visto

Prof.ssa Marisa Calzolari

AZIENDA OSP. S. CATERINA DEL RENO
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
Prof.ssa M. Calzolari
Ord. Medici BO n. 11307

(1) Consenso scritto e dichiarazione di non comunicazione ai familiari acquisiti il 03/09/2025, prot. n. MI/2025/00877; in caso di urgenza contattare esclusivamente il sig. S. Viola (+39 349 562 0718).
(2) Test farmacogenetico eseguito prima di un eventuale uso di abacavir; nessuna indagine genetica estesa ai familiari.
(3) La notifica di caso di AIDS al sistema di sorveglianza è stata effettuata in forma anonima, senza dati identificativi del sig. D'Ambrosio.